

Dysphagia Lusoria

異常右鎖骨下動脈壓迫食道

Aberrant Right Subclavian Artery — NEJM Images in Clinical Medicine

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC · 2026-06-04

原文：[N Engl J Med 2026 \(DOI 10.1056/NEJMicm2600585\)](https://doi.org/10.1056/NEJMicm2600585)

病例 (Case)

- 44 歲男性，腦性麻痺；4 年進食噎咳
- 曾治逆流 (PPI) + 食物質地調整，症狀持續
- 內視鏡：上段食道後壁搏動性、條索狀結構壓迫
- CT：異常右鎖骨下動脈 (ARSA)，主動脈弓第 4 分支，走行食道後方

診斷：Dysphagia lusoria。

什麼是 Dysphagia Lusoria

- **ARSA / arteria lusoria**：最常見先天主動脈弓分支異常（~0.5–2%）
- 為弓部**最後一支**、起點在左鎖骨下遠端，**~80% 走行食道後方** → 壓迫
- 多數**無症狀**；有症狀才稱 dysphagia lusoria
- **中年才發病**：血管**硬化/延長**後壓迫加劇

成人新發、進行性吞嚥困難 + 食道後壁搏動壓迫 → 想到血管性病因。

診斷工具

工具	典型發現
Barium swallow	食道後壁斜向 壓痕
CT / CTA	ARSA 走行、有無 Kommerell 憩室
內視鏡	黏膜外 搏動性 壓迫 (勿誤為可切腫瘤)

處置與心臟科須知

- **輕度** → 保守（飲食調整、吞嚥/語言治療）— 本例 3 個月改善
- **嚴重/難治** → 外科：ARSA **離斷 + 再植**
- 心血管須知：
 - **Kommerell 憩室** → 破裂/剝離風險，需追蹤
 - **非返喉神經** → 頸部/甲狀腺手術神經走行異常，易受傷

Take-home

1. 成人進行性吞嚥困難 + 食道後壁搏動性壓迫 → **dysphagia lusoria (ARSA)** 。
2. 最常見弓部分支異常；中年血管硬化後才出症狀。
3. 輕度保守、嚴重外科離斷再植。
4. 留意 **Kommerell 憩室**與**非返喉神經**。

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

原文 : *N Engl J Med* 2026 · DOI 10.1056/NEJMicm2600585